ESCUTA - COMPORTAMENTO - RELAÇÕES

TODO MUNDO FALA. QUEM AINDA ESCUTA?

A hipótese de uma epidemia da não escuta e a ditadura da própria realidade.

Uma leitura acessível, com ciência e vida cotidiana, sobre atenção, empatia, comportamento verbal e o que acontece quando conversar vira apenas esperar a própria vez.

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO | EMPATIA | VIDA REAL

Gabriel Batista
Neuropsicólogo - CRP 06/176184
Neuropsicologia aplicada à vida real

ANTES DE CHAMAR DE EPIDEMIA

Talvez nunca tenhamos falado tanto. Isso não significa que aprendemos a escutar.

Aqui, "epidemia" é uma provocação editorial, não uma taxa epidemiológica. A pergunta é: alguns repertórios de escuta estão sendo pouco exercitados?

Três cenas fáceis de reconhecer

1. **Responder antes de entender.**
   A pessoa ainda constrói a ideia e a nossa defesa já nasceu.
2. **Disputar protagonismo.**
   A história do outro vira uma ponte para contar a nossa.
3. **Transformar diferença em erro.**
   "Eu faria diferente" vira "você está errado".

O que a pesquisa encontrou

Em dois estudos pré-registrados com 646 participantes, validação verbal e perguntas de acompanhamento apareceram ligadas a marcadores de maior conexão social.

Isso não prova uma "epidemia". Mostra que comportamentos concretos de escuta podem ser observados e estudados. (WEST et al., 2025)



O outro corre o risco de desaparecer quando só toleramos o que confirma aquilo que já pensamos.

SÍNTESE INSPIRADA EM BYUNG-CHUL HAN

SAÚDE MENTAL NÃO COMEÇA NO CÓDIGO

Entre "não é nada" e "é um transtorno" existe um território clínico inteiro.

Ansiedade, tristeza, irritabilidade, insônia, queda de concentração, evitação e até crise de pânico podem aparecer sem, sozinhos, fecharem um diagnóstico.

1. Sinal ou sintoma

Algo mudou e merece atenção. Um sintoma isolado não equivale automaticamente a transtorno.

2. Padrão + impacto

Frequência, duração, intensidade, prejuízo, risco e repetição ajudam a mostrar o peso clínico.

3. Avaliação diagnóstica

Exige história, critérios, diagnóstico diferencial e investigação do contexto biopsicossocial.

Rastreamento não é diagnóstico

A equipe pode perceber antes de ter certeza. Rastrear é identificar sinais que merecem investigação; diagnosticar exige avaliação.

O que a Psicologia acrescenta

Padrões de comportamento, sofrimento subjetivo, habilidades sociais, história de aprendizagem, impacto funcional e contingências ambientais.

> **Uma frase para guardar:** nem todo sofrimento é transtorno. Todo sofrimento relevante merece escuta.

A TEORIA ENTRA DEPOIS DA CENA

Escutar também é comportamento.

Em vez de adivinhar uma "essência de bom ouvinte", podemos observar o que acontece antes, o que a pessoa faz e o que acontece depois.

A - Antes

Estou cansado? Com pressa? Espero crítica? O celular chamou? Quero convencer?

B - Durante

Interrompo? Pergunto? Rebato? Resumo? Olho o celular? Mudo de assunto?

C - Depois

Houve alívio, aproximação, silêncio, discussão, atenção ou encerramento?

Exemplo de 20 segundos

O celular vibra. Você olha "só um instante". Encontra novidade ou alívio da tensão. Se isso se repete, a tela pode competir com a atenção que a conversa exige.

Skinner, sem jargão

O comportamento não aparece no vácuo. Ele se relaciona com contexto, história e consequências. Duas interrupções iguais na aparência podem ter funções diferentes. (SKINNER, 1953)

Na linguagem técnica: antecedentes, resposta e consequências. **Na vida real:** o que veio antes, o que eu fiz e o que isso produziu.

VOCÊ ESCUTA OU ESPERA A SUA VEZ?

Às vezes, a pessoa ainda fala. A nossa resposta já está pronta.

"Ela está na terceira frase. Sua defesa está pronta desde a primeira."

"Você perguntou como ela estava. Quando ela responde, você conta como você está."

"Ela traz um problema. Você oferece solução antes de descobrir se ela queria ajuda."

Fuga e esquiva, em português comum

Fuga: faço algo para encerrar um desconforto que já começou.

Esquiva: faço algo para impedir que um desconforto aconteça.

Interromper, ironizar, racionalizar, atacar a forma como a pessoa falou ou mudar de assunto **podem** funcionar assim em alguns contextos.

Pergunta funcional

O que eu ganho, evito ou encerro quando paro de escutar?

Importante: comportamento não é diagnóstico moral. A mesma forma pode ter funções diferentes.

QUANDO MINHA HISTÓRIA VIRA RÉGUA

Minha experiência é um dado. Não é uma lei universal.



"Quando fui escutado e ouvido, consegui perceber meu mundo de uma nova maneira."

CARL ROGERS - TRADUÇÃO LIVRE

Rogers descreve a empatia como tentativa de compreender o mundo interno do outro a partir da referência do próprio outro, sem perder a própria identidade.

Frases que parecem normais

"Eu consegui, então qualquer pessoa consegue."
"Para mim foi fácil."
"Na minha época isso não era problema."

O que a Análise do Comportamento acrescenta

Histórias diferentes constroem repertórios diferentes. Família, renda, cultura, oportunidades, violência, reforçadores e punições alteram o que uma pessoa aprendeu a fazer.

Pergunta que muda a conversa:
"O que eu ainda não sei sobre a história dessa pessoa?"

A ditadura da própria realidade

Ela começa quando a diferença deixa de ser informação e passa a ser tratada como afronta.

TRÊS COISAS DIFERENTES

Escutar. Validar. Concordar.

Escutar

Prestar atenção suficiente para compreender o que está sendo comunicado.

Validar

Reconhecer que uma emoção ou experiência faz sentido para aquela pessoa naquele contexto.

Concordar

Aderir à interpretação, decisão ou conclusão apresentada.

> **"Eu entendo por que isso doeu"** não significa **"acho correto tudo o que você fez depois disso".**

Micro-censura cotidiana

Às vezes ninguém proíbe você de falar. Só deixam claro o preço de dizer determinadas coisas.

Trabalho
"Pode opinar." Você discorda. Depois, sua presença some das decisões.

Relacionamento
"Pode falar comigo." Você fala. Recebe ironia, silêncio punitivo ou retaliação.

Família
"Aqui todo mundo conversa." Alguém questiona uma tradição e vira "o problemático".

QUANDO O NOME CHEGA ANTES DA HISTÓRIA

Encontrar um diagnóstico não encerra uma investigação.

Diagnósticos podem organizar cuidado, favorecer acesso e dar nome a sofrimentos reais. Mas sintoma, sofrimento e transtorno não são sinônimos.

Dois erros cabem na mesma pressa

Transformar sofrimento em transtorno sem investigar, ou chamar de "coisa da vida" um quadro que já produz prejuízo importante.

Diagnóstico é ferramenta

Ele deve ampliar possibilidades de cuidado. Não esgota identidade, contexto nem possibilidade de mudança.

Três riscos da escuta apressada

1. Ancoragem: tudo passa a ser explicado pelo primeiro rótulo.

2. Identidade rígida: "sou assim porque tenho X" vira regra absoluta.

3. Contexto apagado: sono, trauma, saúde física, relações, trabalho e condições sociais somem.

Perspectiva biopsicossocial: um bom cuidado não precisa escolher entre biologia, psicologia e contexto social. Precisa integrá-los.

VOCÊ ESTÁ LÁ. MAS ESTÁ PRESENTE?

Escuta ativa não é presença física. É presença percebida.



A tela pode competir com a relação

Uma meta-análise de 52 estudos, 58 amostras e 19.698 participantes encontrou associação entre partner phubbing e menor satisfação relacional, intimidade, responsividade e maior conflito.

A maior parte da literatura é correlacional, portanto associação não é sinônimo de causalidade. (Nl et al., 2025)



"Minha experiência é aquilo a que concordo em prestar atenção."

WILLIAM JAMES - TRADUÇÃO LIVRE

Escuta que acolhe x "estar ali"

Estar ali: silêncio, respostas automáticas, atenção dividida.

Acolher: compreender, verificar, demonstrar curiosidade e responder ao que realmente foi dito.

Pergunta rápida: depois de falar comigo, o outro sente que foi percebido ou apenas que eu estava fisicamente presente?

O QUE FAZER EM UMA CONVERSA REAL

Pequenas atitudes mudam a experiência de quem fala.

1. **Deixe a pessoa terminar.** Não preencha todo silêncio.
2. **Faça perguntas de continuidade.** "O que aconteceu depois?"
3. **Verifique entendimento.** "Entendi que você quis dizer... é isso?"
4. **Reconheça a emoção.** Sem transformar validação em concordância.
5. **Guarde o celular.** Especialmente em conversas importantes.
6. **Repare quando falhar.** "Eu te interrompi. Continua."
7. **Não roube a história.** Sua experiência pode esperar alguns minutos.
8. **Pergunte o que a pessoa precisa.** Escuta, opinião ou ajuda para resolver?

Pergunta de bolso

"Você quer que eu apenas escute, quer minha opinião ou quer pensar em soluções comigo?"



"A atenção é a forma mais rara e mais pura de generosidade."

SIMONE WEIL - TRADUÇÃO LIVRE

FALAR TAMBÉM É CUIDAR

Tudo bem não estar pronto para conversar. O importante é não desaparecer da conversa.

Pausa pode ser autorregulação. Mas vira esquiva quando serve apenas para fugir e nunca existe retorno.

Frases honestas

"Quero te ouvir, mas agora estou reativo. Posso respirar e voltamos às 20h?"

"Esse assunto importa. Preciso de 20 minutos para organizar meus pensamentos e volto."

"Não consigo conversar bem enquanto estamos gritando. Quero continuar quando diminuirmos o tom."

Uma regra simples

Pausa só é cuidado quando existe uma ponte de volta.

Combine um horário, cumpra o retorno e reconheça se adiou além do combinado.

Quando não é hora de insistir

Se houver risco, ameaça, violência, intoxicação importante ou perda grave de controle, priorize segurança e ajuda adequada.

Escutar não é se abandonar. Limites claros podem proteger a conversa e o vínculo.

EXERCÍCIO INTERATIVO - PARTE 1

Quais barreiras aparecem quando você tenta escutar?

Pense nas últimas quatro semanas. Marque: **0 nunca - 1 raramente - 2 às vezes - 3 frequentemente.**

Este exercício faz uma aferição exploratória e autorreferida. Não é teste psicológico, não produz diagnóstico e não mede personalidade.

#	Barreiras à escuta	0	1	2	3
1	Enquanto alguém fala, preparo mentalmente a minha resposta.	○	○	○	○
2	Interrompo para corrigir detalhes ou explicar o que eu penso.	○	○	○	○
3	Completo frases de outras pessoas.	○	○	○	○
4	Olho notificações ou mexo no celular durante conversas importantes.	○	○	○	○
5	Quando me sinto criticado, começo a me defender antes de a pessoa terminar.	○	○	○	○
6	Dou conselhos antes de perguntar se a pessoa quer conselho.	○	○	○	○
7	Transformo rapidamente a experiência da pessoa em uma história minha.	○	○	○	○
8	Mudo de assunto quando a conversa começa a me deixar desconfortável.	○	○	○	○
9	Faço perguntas principalmente para provar meu ponto.	○	○	○	○
10	Presumo saber o que a pessoa quis dizer antes de verificar.	○	○	○	○
11	Uso ironia, sarcasmo ou mudança de foco quando discordo.	○	○	○	○
12	Depois da conversa, lembro pouco do que a pessoa realmente disse.	○	○	○	○

Não consulte o resultado ainda. Apenas responda. Some seus pontos no final e guarde o número para o Anexo.

EXERCÍCIO INTERATIVO - PARTE 2

Sua escuta acolhe ou você apenas está presente?

Use a mesma escala: **0 nunca - 1 raramente - 2 às vezes - 3 frequentemente.**

Aqui você observa comportamentos de escuta ativa: atenção, compreensão, validação, curiosidade e reparo.

#	Repertório de escuta	0	1	2	3
13	Faço perguntas ligadas ao que a pessoa acabou de dizer.	○	○	○	○
14	Tolero alguns segundos de silêncio sem preencher imediatamente.	○	○	○	○
15	Verifico se entendi corretamente antes de tirar conclusões.	○	○	○	○
16	Reconheço uma emoção sem precisar concordar com a conclusão.	○	○	○	○
17	Consigo ouvir uma crítica inteira antes de começar a me defender.	○	○	○	○
18	Pergunto se a pessoa quer escuta, opinião ou ajuda para resolver.	○	○	○	○
19	Deixo o celular de lado em conversas importantes.	○	○	○	○
20	Percebo mudanças relevantes no tom, ritmo ou expressão do outro.	○	○	○	○
21	Consigo admitir quando uma informação mudou minha interpretação.	○	○	○	○
22	Lembro depois de informações importantes que alguém compartilhou.	○	○	○	○
23	Quando interrompo ou entendo errado, consigo reparar e devolver a palavra.	○	○	○	○
24	Demonstro curiosidade por realidades diferentes das minhas.	○	○	○	○

Agora some apenas esta página. Guarde também este número. Os dois resultados serão lidos separadamente no Anexo.

NEM TODA FALHA DE ESCUTA TEM A MESMA ORIGEM

Contextualizar não é retirar responsabilidade.

Sono, dor, ansiedade, depressão, estresse, substâncias, neurodesenvolvimento, sobrecarga, violência, cultura e condições econômicas podem mudar atenção e disponibilidade.

Biológico

Sono, dor, saúde física, medicação e substâncias.

Psicológico

Ansiedade, humor, trauma, história de aprendizagem e repertórios.

Social

Relações, cultura, poder, trabalho, renda e condições de vida.

Escuta também é institucional

Saúde: consulta curta demais para compreender a história.
Assistência social: demanda transformada apenas em formulário.
Educação: escuta que só começa depois da crise.

Trabalho: canal de fala sem consequência real.
Políticas públicas: decisões que contam números, mas não experiências.

Uma sociedade que escuta melhor precisa de instituições capazes de responder ao que ouvem.

Quando vale buscar ajuda: quando conflitos, explosões, isolamento ou incapacidade de sustentar conversas difíceis começam a afetar repetidamente relações, trabalho, estudo ou bem-estar.

A PERGUNTA QUE FICA

Talvez você fale muito bem. A pergunta é: alguém consegue existir enquanto você fala?

Escutar não exige abandonar opinião, história ou limites. Exige permitir que outra história tenha espaço suficiente para produzir algum efeito.

Uma conversa deixa pistas. Algumas pessoas saem dela mais compreendidas e capazes de pensar. Outras saem corrigidas, culpadas ou cansadas de tentar explicar.

Compreender não é justificar. A Análise do Comportamento pergunta o que sustenta um padrão. Rogers lembra que o outro possui um mundo interno. As habilidades sociais transformam isso em repertórios treináveis.

Como é conversar comigo?

1. Você consegue terminar suas frases quando fala comigo?
2. Quando discorda, sente que eu tento compreender antes de responder?
3. Minhas perguntas parecem curiosidade ou tentativa de provar um ponto?
4. Existe algo que eu faço que faz você desistir de conversar comigo?
5. O que eu poderia fazer para você se sentir mais ouvido?



"A atenção é a forma mais rara e mais pura de generosidade."

SIMONE WEIL

Escuta qualificada

Não é apenas estar perto. É produzir no outro a experiência de ter sido percebido.



Gabriel Batista
Neuropsicólogo - CRP 06/176184
Neuropsicologia aplicada à vida real

ANEXO - CONSULTE SÓ DEPOIS DE RESPONDER

Agora, veja o que os seus dois números sugerem.

Não existe "veredito". As faixas organizam a frequência autorreferida dos comportamentos para estimular reflexão.

Parte 1 - Barreiras à escuta

0 a 12 - Barreiras pouco frequentes
Sua atenção tende a sofrer menos interferência desses padrões.

13 a 24 - Barreiras aparecem sob tensão
Pressa, defesa, distração ou competição podem atrapalhar em alguns contextos.

25 a 36 - Barreiras frequentes
A conversa pode estar virando defesa, esquiva ou disputa com regularidade.

Parte 2 - Repertório de escuta

0 a 12 - Em construção
Você pode estar presente sem necessariamente produzir acolhimento percebido.

13 a 24 - Presente, mas oscilante
Há recursos de escuta, mas eles podem cair sob tensão ou distração.

25 a 36 - Mais consistente
Os comportamentos de atenção, compreensão e reparo aparecem com maior frequência.

Cruze os dois resultados

Poucas barreiras + repertório alto
Você tende a acolher com presença. Continue pedindo feedback ao outro.

Poucas barreiras + repertório baixo
Você pode estar quieto sem necessariamente escutar ativamente. Treine perguntas e verificação.

Muitas barreiras + repertório alto
Você sabe escutar, mas pode perder o repertório quando se sente ameaçado. Use pausa com retorno.

Muitas barreiras + repertório baixo
A conversa pode estar sendo dominada por defesa, pressa ou esquiva. Comece por uma técnica de cada vez e considere ajuda se houver impacto relevante.

Importante: esta aferição é educativa e exploratória. Não possui normas populacionais, valor diagnóstico ou validade psicométrica estabelecida.

BASES PARA CONCORDAR, DISCORDAR E INVESTIGAR

Referências e transparência editorial

Esta edição propõe uma hipótese e convida à observação. A expressão "epidemia da não escuta" é metáfora editorial, não taxa epidemiológica demonstrada.

BRADFORD, A. et al. Diagnostic error in mental health: a review. BMJ Quality & Safety, v. 33, n. 10, p. 663-672, 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Rastreamento/diagnóstico - transtornos de ansiedade no adulto. Linhas de Cuidado. Brasília, DF, [s.d.].

BRASIL. Ministério da Saúde. Pesquisa Nacional de Saúde Mental realiza coleta de dados em 197 municípios. Brasília, DF, 3 set. 2026.

DEL PRETTE, A.; DEL PRETTE, Z. A. P. Competência social e habilidades sociais: manual teórico-prático. Petrópolis: Vozes, 2017.

FRANCES, A. Saving normal: an insider's revolt against out-of-control psychiatric diagnosis. New York: William Morrow, 2013.

HAN, B.-C. A expulsão do outro. Lisboa: Relógio D'Água, 2018.

JAMES, W. The principles of psychology. New York: Henry Holt, 1890.

NI, N.; AHRARI, S.; ZAREMOHZZABIEH, Z.; ZAREAN, M.; ROSLAN, S. A meta-analytic study of partner phubbing and its antecedents and consequences. Frontiers in Psychology, v. 16, 2025. DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1561159.

ROGERS, C. R. Um jeito de ser. São Paulo: EPU, 1983. Original publicado em 1980.

SKINNER, B. F. Science and human behavior. New York: Macmillan, 1953.

WEIL, S. Carta a Joë Bousquet, 13 abr. 1942. In: Correspondance. Lausanne: L'Age d'Homme, 1982.

WEST, T. N.; HUSTON, S.; CHANDLER, K. R.; ZHOU, J.; FREDRICKSON, B. L. High-quality listening behaviors linked to social connection between strangers. Communications Psychology, v. 3, art. 165, 2025. DOI: 10.1038/s44271-025-00342-2.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Mental disorders. Geneva: WHO, 2025.

Sobre o checklist

Os escores servem para auto-observação e curiosidade. Não são pontos de corte clínicos e não substituem avaliação psicológica ou multiprofissional.

Sobre as citações

As frases de Rogers, James e Weil aparecem em tradução livre e foram usadas como pequenos convites à reflexão, sem substituir a leitura das obras originais.

Ideia central: uma escuta qualificada não é uma performance de técnicas. É atenção, compreensão, resposta e capacidade de reparar quando falhamos.